# DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTO : | HOSPITAL SAN CARLOS | N°DAU : | 3984402 |
| CALIDAD : | Original | FECHA : | 07/02/2025 18:04 |
| AREA : | U.E. Adulto | BOX : | 3 |
| HC : | 0 | CTA. CTE. : | 0 |

## DATOS CONSULTANTE:

**Nombre** : LUIS ALBERTO BRIONES JIMENEZ **RUN** : 7.990.570-4 **CP** : 637878
**Previsión** : FONASA B **F.Nac** : 08/02/1956 **Género** : Masculino **Edad** : 69 Años 0
**Dirección** : EL LAUREL 896 POB. 11 SEPT ACT **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 995082010

## DATOS INGRESO:

**Procedencia** : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
**Lug. Ocurrencia** : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : SAMU 1

## SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 07/02/2025 18:18:50;

**Profesional** : Cynthia Ortega Molina **Hra. Llamada** : 07/02/2025 18:18 **Hora Atención** : 07/02/2025 18:24
**T° Axilar** : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 70 **Frec. Resp.** : 0
**Saturometría** : 97 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
**Motivo de consulta:** : TRAIDO POR M1POR UNA SEMANA DE CEG, CON UROC POSITIVO PARA VER INICIO DE TTO ATB
SAT95 FR 20 HGT 128 PA 95/68 FC 77
AM TQT CUP COLOSTOMIA GASTROSTOMIA PARKINSON ATROFIA MUSCULAR DISAUTONOMIA Y ANEMIA
ALERGIA NO

## CONTROL SIGNOS VITALES:

| Fecha | Pulso | Presión | T° Axilar | T° Rectal | FR | Sat. | HGT | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 19:43 | 88 | 113/63 | 37.5 | | | 97 | | María Alejandra Celedón Gajardo |
| 08/02/2025 07:08 | 74 | 90/58 | 36.5 | | | 95 | 89 | Paz Fabres Sepúlveda |

## ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

**INFORME LESIONES** : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

## ANAMNESIS:

| Fecha | Anamnesis | Profesional |
|---|---|---|
| 07/02/2025 18:34 | AM: ENF. DE PERKINSON CON ATROFIA MULTICISTEMICA.<br>- QX: VOLVULO INTESTINAL USUARIO DE TQT, GTT Y COLOSTOMIA.<br>- RAM: NIEGA.<br><br>PACIENTE TRAIDO POR AMBULANCIA DESDE DOMICILIO POR INICIAR DESDE HACE 1 SEMANA SECRECION URETRAL POR LO QUE ACUDEN DESDE APS A DOMICILIO PARA TOMA DE UC Y CULTIVO CORRIENTE DE SECRECION URETRAL LOS CUALES DESTACAN: OC INFLAMATORIA CON AISLAMIENTO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA; MOTIVO POR EL CUAL ACUDEN. AL INTERROGATORIO DIRIGIDO A ESPOSA DEL PACIENTE, NIEGA FIEBRE, NIEGA EMESIS, NIEGA COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL. | MARIA GABRIELA ARANGUIBEL BARBOZA |
| 07/02/2025 20:51 | se recibe paciente del turno anterior, quien se encuentra en espera de resultados de laboratorio | MARIYER MENDOZA PULIDO |
| 07/02/2025 21:53 | PACIENTE DE 69 AÑOS CON ANTECEDENTES DE ATROFIA MULTISISTEMICA-DISAUTONOMIA-PARKINSON-POSTRADO, USUARIO DE TQT, COLOSTOMIA Y GASTROSTOMIA. EN VISTA DE MARCADORES INFLAMATORIOS ELEVADOS CON UROCULTIVO Y SECRESION URETRAL CON PATOGENOS NOSOCOMIALES CON SENSIBILIDAD A ABT DE SEGUNDA LINEA, SE DECIDE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA ADMINISTRACION DE ERTAPENEM 1 GR CADA 24 HORAS POR 7 DIAS, CON VALORACION MEDICA Y CONTROL DE EXAMENES EL LUNES 10/02/2025. FAMILIAR COMUNCA BUENA RED DE APOYO PARA MONITORIZAR CONDICIONES CLINICAS DEL PACIENTE, EN COMPAÑIA DE ENFERMERA GESTIONADA POR FAMILIARES PARA EL CUIDADO DE DON LUIS. | MARIYER MENDOZA PULIDO |

## EXAMEN FÍSICO :

| Fecha | Examen Físico | Profesional |
|---|---|---|
| 07/02/2025 18:54 | PACIENTE POSTRADO EN ECG, TRANQUILO Y COOPERADOR, HDE, AFEBRIL. ABDOMEN CON PRESENCIA DE GTT Y COLOSTOMIA IN SITU, BLANDO, DEPRESIBLE, DOLOROSO A LA PALPACION DE HEMIABDOMEN INFERIOR, BLUMBERG (-), RHA (+) NORMOACTIVOS. | MARIA GABRIELA ARANGUIBEL BARBOZA |

## DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

| Fecha | Hipótesis diagnóstica | Profesional |
|---|---|---|
| 07/02/2025 21:51 | N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | MARIYER MENDOZA PULIDO |
| 07/02/2025 21:51 | R36 DESCARGA URETRAL | MARIYER MENDOZA PULIDO |

## PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

| Fecha | Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos | Profesional | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 21:14 | por favor realizar aspiracion de TQT | MARIYER MENDOZA PULIDO | Ejecutado el 07/02/2025 21:36 | VÍCTOR IGNACIO MUÑOZ ASTUDILLO<br>Obs:eu constanza herrera |
| 07/02/2025 21:52 | ertapenem 1 gr EV STAT | MARIYER MENDOZA PULIDO | Ejecutado el 08/02/2025 00:15 | VÍCTOR IGNACIO MUÑOZ ASTUDILLO |

## EXAMENES:

| Fecha | Examen | Profesional |
|---|---|---|
| 07/02/2025 18:46 | VHS ; RCTO GLOBULAR ; CREATININEMIA ; PCR ; | MARIA GABRIELA ARANGUIBEL BARBOZA |
| 07/02/2025 21:54 | VHS ; RCTO GLOBULAR ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PCR ; | MARIYER MENDOZA PULIDO |

## INDICACIONES ALTA:

| Fecha | Indicación | Profesional |
|---|---|---|
| 07/02/2025 21:53 | SE INDICA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA<br>ERTAPENEM 1 GR EV CADA 24 HORAS POR 7 DIAS<br>CONTROL CON MEDICO Y EXAMENES EL LUNES 10/02/25<br><br>PACIENTE DE 69 AÑOS CON ANTECEDENTES DE ATROFIA MULTISISTEMICA-DISAUTONOMIA-PARKINSON-POSTRADO, USUARIO DE TQT, COLOSTOMIA Y GASTROSTOMIA. EN VISTA DE MARCADORES INFLAMATORIOS ELEVADOS CON UROCULTIVO Y SECRESION URETRAL CON PATOGENOS NOSOCOMIALES CON SENSIBILIDAD A ABT DE SEGUNDA LINEA, SE DECIDE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA PARA ADMINISTRACION DE ERTAPENEM 1 GR CADA 24 HORAS POR 7 DIAS, CON VALORACION MEDICA Y CONTROL DE EXAMENES EL LUNES 10/02/2025. FAMILIAR COMUNCA BUENA RED DE APOYO PARA MONITORIZAR CONDICIONES CLINICAS DEL PACIENTE, EN COMPAÑIA DE ENFERMERA GESTIONADA POR FAMILIARES PARA EL CUIDADO DE DON LUIS. | MARIYER MENDOZA PULIDO |

## RECETAS:

| Fecha | Prescripción | Profesional |
|---|---|---|

## OBSERVACIONES:

| Fecha | Indicación | Profesional |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 07/02/2025 19:48 | Se instala vvp18 en mano derecha, se toman exámenes sanguíneos solicitados | Elizabeth Fierro Palma |
| 07/02/2025 21:15 | Creatinina : 0,40 *<br>Clearence Calculado(MDRD) : 213,29<br>Proteina C Reactiva : 22,5<br>Hemoglobina : 9,5 *<br>Hematocrito : 29,3 *<br>Recuento de leucocitos : 6,90<br>Recuento Hematies : 3,62 *<br>Plaquetas : 272<br>Segmentados : 64,8<br>Linfocitos : 19,4<br>V.H.S. : 49 | MARIYER MENDOZA PULIDO |
| 07/02/2025 21:17 | 03/2/25<br>secresion uretral<br>AISLAMIENTO 1<br>Aislamiento : Pseudomonas aeruginosa<br>Ceftazidima : Sensible ( CIM: 4 ug/mL )<br>Ciprofloxacino : Intermedio<br>Imipenem : Sensible ( CIM: 1 ug/mL )<br>Meropenem : Sensible ( CIM: <=0,5 ug/mL )<br>Piperacilina-Tazobactam : Sensible ( CIM: 8/4 ug/mL )<br><br>AISLAMIENTO 2<br>Aislamiento : Pseudomonas aeruginosa<br>Ceftazidima : Sensible ( CIM: 4 ug/mL )<br>Ciprofloxacino : Sensible<br>Imipenem : Sensible ( CIM: 1 ug/mL )<br>Meropenem : Sensible ( CIM: 2 ug/mL )<br>Piperacilina-Tazobactam : Sensible ( CIM: 16/4 ug/mL )<br><br>AISLAMIENTO 3<br>Aislamiento : Enterococcus faecalis<br>Ampicilina : Sensible<br>Vancomicina : Sensible | MARIYER MENDOZA PULIDO |
| 07/02/2025 21:18 | urocultivo<br>03/2/25<br>AISLAMIENTO 1<br>Aislamiento : Pseudomonas aeruginosa<br>Amikacina : Sensible<br>Ceftazidima : Sensible<br>Ciprofloxacino : Intermedio<br>Imipenem : Sensible<br>Meropenem : Sensible<br>Piperacilina-Tazobactam : Sensible<br><br>AISLAMIENTO 2<br>Aislamiento : Enterococcus faecalis<br>Ampicilina : Sensible ( CIM: <=2 ug/mL )<br>Ciprofloxacino : Resistente ( CIM: >2 ug/mL )<br>Nitrofurantoína : Sensible ( CIM: <=16 ug/mL )<br>Vancomicina : Sensible ( CIM: 1 ug/mL ) | MARIYER MENDOZA PULIDO |

**GES** : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

**ADVERTENCIA**
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA



MARIYER MENDOZA PULIDO
26.362.383-5